विद्यालयीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

School Health Programme

अर्थ एवं संकल्पना (Meaning and Concept)

विद्यालयीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (**School Health Programme**) विद्यालय से जुड़े बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए नियोजित गतिविधियों तथा सेवाओं का समन्वित रूप है। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा, बीमारी की पहचान, आवश्यक सेवा से जुड़ाव और स्वस्थ विद्यालय वातावरण शामिल हैं।

यह कार्यक्रम केवल वर्ष में एक बार डॉक्टर बुलाकर जाँच कराने तक सीमित नहीं है। भोजन, पानी, शौचालय, सुरक्षा, खेल, संबंध और दैनिक शिक्षण-व्यवहार भी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

कार्यक्रम का व्यापक क्षेत्र (Scope)

प्रमुख पक्ष	उदाहरण
स्वास्थ्य संवर्धन	स्वस्थ आदतें, जीवन-कौशल और सक्रिय जीवन
रोग-निवारण	टीकाकरण से जुड़ाव, स्वच्छता और पोषण
स्वास्थ्य सेवा	आकलन, रेफरल और उपचार का अनुवर्तन
सुरक्षित वातावरण	भवन, पानी, भोजन और भावनात्मक सुरक्षा
सहभागिता	परिवार, विद्यार्थी, शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी

विद्यालय की विशिष्ट भूमिका (Why Schools Matter)

बच्चे दिन का महत्त्वपूर्ण भाग विद्यालय में बिताते हैं। यहाँ नियमित संपर्क, समूह-अधिगम और व्यवहार के अभ्यास का अवसर मिलता है। स्वास्थ्य समस्या की पहचान सीखने तथा उपस्थित रहने में बाधा कम कर सकती है।

विद्यालय का स्वास्थ्य प्रयास कर्मचारियों और परिवारों तक भी सकारात्मक प्रभाव पहुँचा सकता है। फिर भी विद्यालय से बाहर के बच्चों की जरूरत के लिए समुदाय तथा स्वास्थ्य-व्यवस्था का अलग संपर्क आवश्यक है।

> स्वस्थ विद्यालय वह है जहाँ पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता को रोज के जीवन में स्थान मिले।

आवश्यकता, उद्देश्य और अपेक्षित लाभ

Need, Objectives and Expected Benefits

स्वास्थ्य और अधिगम का संबंध (Health and Learning)

कम दिखना, कम सुनना, दंत-दर्द, भूख, एनीमिया या भावनात्मक परेशानी बच्चे की कक्षा में सहभागिता प्रभावित कर सकती है। कई समस्याएँ जल्दी पहचानी जाएँ तो उपचार या अनुकूलन से लाभ मिलता है।

कार्यक्रम के उद्देश्य (Objectives)

उद्देश्य	व्यवहार में अर्थ
स्वास्थ्य संरक्षण	बीमारी और चोट के जोखिम घटाना
स्वास्थ्य संवर्धन	उपयोगी आदतें और निर्णय-कौशल विकसित करना
शुरुआती पहचान	संकेत देखकर समय पर उपयुक्त जाँच
सेवा से जुड़ाव	जरूरत पर उपचार और अनुवर्तन
समान अवसर	अलग जरूरतों और बाधाओं के अनुरूप सहयोग
विद्यालयी सहभागिता	स्वास्थ्य के कारण होने वाली रुकावट कम करना

तत्काल और दीर्घकालीन लाभ (Short- and Long-term Benefits)

तत्काल लाभ में दर्द का उपचार, चश्मे की उपलब्धता या सुरक्षित पानी जैसी सुविधाएँ हो सकती हैं। दीर्घकालीन लाभ स्वस्थ व्यवहार, बेहतर स्वास्थ्य-साक्षरता और सुरक्षित संबंधों से जुड़ते हैं।

केवल अनुपस्थिति घटने को सफलता का पूरा माप न मानें। बीमार बच्चे को जबरन उपस्थित रखना स्वास्थ्य उद्देश्य के विपरीत है। उपयुक्त आराम तथा सुरक्षित विद्यालय-वापसी भी आवश्यक है।

अधिकार और गरिमा (Dignity and Access)

स्वास्थ्य सेवा गरीबी, लिंग, भाषा या अक्षमता के आधार पर अलग व्यवहार किए बिना उपलब्ध हो। किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण बच्चे को दोष देना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना उचित नहीं है।

> कार्यक्रम की सफलता स्वस्थ जीवन के अवसर बढ़ने से आँकी जाती है, केवल गतिविधियों की संख्या से नहीं।

विद्यालयीय स्वास्थ्य के मार्गदर्शक सिद्धांत

Guiding Principles of School Health

समग्रता और निरंतरता (Comprehensiveness and Continuity)

शरीर, भावना, संबंध और वातावरण एक-दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए स्वास्थ्य कार्यक्रम में अलग गतिविधियों को जोड़ना और पूरे वर्ष संपर्क बनाए रखना आवश्यक है।

सिद्धांत	व्यावहारिक उपयोग
आयु-अनुकूलता	छोटे और बड़े बच्चों के लिए अलग भाषा तथा गतिविधि
सहभागिता	विद्यार्थियों और परिवारों की बात सुनना
समावेशन	जरूरत के अनुसार सामग्री और सुविधा बदलना
वैज्ञानिकता	सही जानकारी और योग्य सेवा का उपयोग
गोपनीयता	निजी जानकारी केवल आवश्यक व्यक्ति तक रखना
व्यवहारिकता	उपलब्ध संसाधन तथा स्थानीय जरूरत के अनुसार योजना

निवारण और उपचार का संतुलन (Prevention and Care)

केवल उपदेश देने से रोग की पहचान तथा उपचार की आवश्यकता समाप्त नहीं होती। केवल चिकित्सा शिविर भी असुरक्षित पानी या हिंसक वातावरण की समस्या हल नहीं करता। दोनों के साथ व्यवस्था में सुधार चाहिए।

विद्यालय और स्वास्थ्य सेवा की सीमा (Appropriate Roles)

शिक्षक संकेत पहचानता, जानकारी देता और संपर्क बनाता है। अंतिम चिकित्सीय निदान तथा उपचार योग्य स्वास्थ्यकर्मी करते हैं। प्रशिक्षित प्राथमिक सहायता और चिकित्सीय उपचार को एक जैसा न मानें।

नियमित समीक्षा (Review and Improvement)

कार्यक्रम में जिम्मेदारी, समय, अभिलेख और परिणाम की समीक्षा स्पष्ट हो। बच्चे तथा परिवार से मिला अनुभव सुधार का उपयोगी आधार है।

> स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चे के लिए हो; बच्चे को केवल जाँच, रिपोर्ट या प्रदर्शन का साधन न बनाया जाए।

विद्यालयीय स्वास्थ्य के तीन मुख्य आधार

Three Core Components of School Health

तीन परस्पर पूरक घटक (Three Core Components)

विद्यालयीय स्वास्थ्य को समझने का प्रचलित ढाँचा स्वास्थ्य शिक्षा, विद्यालयीय स्वास्थ्य सेवाएँ और स्वस्थ वातावरण है। ये अध्ययन की सुविधाजनक श्रेणियाँ हैं; व्यवहार में एक गतिविधि कई पक्षों को जोड़ सकती है।

स्वास्थ्य शिक्षा	स्वास्थ्य सेवाएँ	स्वस्थ वातावरण
Health Education	Health Services	Healthy Environment
समझ, कौशल और स्वस्थ व्यवहार	आकलन, रेफरल और देखभाल	सुरक्षा, सुविधा और सम्मान

शिक्षा से व्यवहार तक (From Education to Practice)

हाथ धोने का महत्त्व समझाना स्वास्थ्य शिक्षा है। पानी, साबुन और पर्याप्त समय देना वातावरण का पक्ष है। दस्त वाले बच्चे का आकलन तथा उपचार से जोड़ना स्वास्थ्य सेवा है। तीनों मिलकर अधिक उपयोगी प्रभाव देते हैं।

गतिविधि	जुड़े हुए घटक
पोषण-अध्यापन और सुरक्षित भोजन	शिक्षा तथा स्वस्थ वातावरण
दृष्टि जाँच और बैठने का अनुकूलन	सेवा तथा अधिगम वातावरण
टीका-संबंधी जानकारी और सेवा-संपर्क	शिक्षा तथा निवारक सेवा
उपहास-निवारण और परामर्श	वातावरण, शिक्षा और सहायता

समन्वय की आवश्यकता (Coordination)

यदि बच्चे को समस्या मिली लेकिन परिवार तक सूचना या उपचार नहीं पहुँचा, तो सेवा अधूरी है। इसी तरह सुविधा बनी होने पर भी उपयोग की जानकारी और रखरखाव न हो तो लाभ सीमित हो सकता है।

विद्यालय की नीति, नेतृत्व और समुदाय का सहयोग इन घटकों को स्थायी बनाते हैं।

> केवल एक घटक पर निर्भर कार्यक्रम की तुलना में समन्वित प्रयास बच्चों की वास्तविक जरूरतों को बेहतर संबोधित करता है।

स्वास्थ्य संवर्धक विद्यालय की अवधारणा

The Health-promoting School

संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण (Whole-school Approach)

स्वास्थ्य संवर्धक विद्यालय (**Health-promoting School**) अपने शिक्षण, काम और दैनिक जीवन को अधिक स्वस्थ तथा सुरक्षित बनाने की क्षमता लगातार बढ़ाता है। इसमें केवल विद्यार्थी का व्यवहार नहीं, संस्थागत निर्णय और संसाधन भी महत्त्वपूर्ण हैं।

आठ वैश्विक मानक-क्षेत्र (Eight Global Standard Areas)

क्षेत्र	मुख्य आशय
सरकारी नीति और संसाधन	शिक्षा-स्वास्थ्य का व्यापक समर्थन
विद्यालय की नीति और संसाधन	स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता
प्रबंधन और नेतृत्व	जिम्मेदारी तथा समन्वय
विद्यालय-समुदाय साझेदारी	परिवार और स्थानीय सेवाओं से सहयोग
पाठ्यचर्या	स्वास्थ्य और जीवन-कौशल का शिक्षण
सामाजिक-संवेगात्मक वातावरण	सुरक्षा, अपनापन और सम्मान
भौतिक वातावरण	स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ परिसर
स्वास्थ्य सेवाएँ	आवश्यक देखभाल तक पहुँच

परस्पर संबंध (Interdependence)

पाठ्यचर्या में स्वच्छता पढ़ाने के साथ बजट में साबुन और पानी का प्रावधान चाहिए। नेतृत्व को निगरानी करनी होगी और विद्यार्थी बताएँगे कि सुविधा उपयोग योग्य है या नहीं। इसी प्रकार नीति व्यवहार में बदलती है।

अन्य ढाँचों से संबंध (Relation to Other Frameworks)

तीन मुख्य आधार और आठ मानक अलग उद्देश्य वाले ढाँचे हैं। पहला मुख्य गतिविधियाँ समझाता है; दूसरा व्यवस्था और कार्यान्वयन की व्यापक शर्तें भी स्पष्ट करता है।

> स्वास्थ्य संवर्धक विद्यालय किसी एक दिवस का आयोजन नहीं; नियमित नीतियों, संबंधों, सेवाओं और सुविधाओं का संयुक्त रूप है।

आवश्यकता आकलन और कार्यक्रम नियोजन

Needs Assessment and Programme Planning

आधारभूत स्थिति जानना (Baseline Assessment)

योजना बनाने से पहले विद्यार्थियों की आयु, स्वास्थ्य जरूरत, अनुपस्थिति, उपलब्ध सुविधाएँ और सेवा तक पहुँच समझें। परिवार, शिक्षक तथा विद्यार्थियों की राय को भी स्थान दें।

जानकारी	उपयोग
स्वास्थ्य अभिलेख	बार-बार मिलने वाली समस्याएँ
परिसर का निरीक्षण	पानी, शौचालय और सुरक्षा की कमियाँ
बच्चों का अनुभव	उपयोग में आने वाली वास्तविक बाधाएँ
स्थानीय सेवा	जाँच, रेफरल और आपात सहयोग की उपलब्धता
उपलब्ध संसाधन	समय, कर्मी और बजट का उपयोग

प्राथमिकता निर्धारण (Prioritization)

समस्या की गंभीरता, प्रभावित बच्चों की संख्या, सुधार की संभावना और उपलब्ध संसाधन साथ देखें। पीने का असुरक्षित पानी तत्काल प्राथमिकता हो सकता है; सभी विषयों पर एक साथ बड़ा अभियान आवश्यक नहीं है।

स्पष्ट लक्ष्य (Specific Goals)

लक्ष्य ऐसा हो जिसे देखा और मापा जा सके। “स्वास्थ्य सुधारना” के साथ यह स्पष्ट करें कि किस सुविधा या सेवा में, कितने समय में और किस जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परिवर्तन होगा।

1	**जरूरत पहचानें**	अभिलेख, सुविधा और अनुभव समझें।
2	**प्राथमिकता और लक्ष्य**	महत्त्वपूर्ण समस्या तथा अपेक्षित सुधार तय करें।
3	**जिम्मेदारी और कार्रवाई**	समय, सामग्री और सेवा-संपर्क जोड़ें।
4	**समीक्षा और सुधार**	नतीजे देखकर योजना में बदलाव करें।

लचीली योजना (Adaptation)

मौसम, स्थानीय रोग, आयु और विशेष जरूरतों के अनुसार गतिविधि बदल सकती है। किसी दूसरे विद्यालय की सूची बिना समीक्षा अपनाना उपयोगी नहीं होता।

> अच्छी योजना जानकारी, प्राथमिकता, जिम्मेदारी और परिणाम की जाँच को एक साथ जोड़ती है।

संगठन, समिति और जिम्मेदारी का बँटवारा

Organization and Allocation of Responsibilities

समन्वित व्यवस्था (Coordination Structure)

विद्यालय नेतृत्व, शिक्षक, परिवार के प्रतिनिधि, विद्यार्थी और संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बीच कार्य-बँटवारा स्पष्ट हो। स्थानीय नियमों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति या उपलब्ध मंच इस समन्वय में भाग ले सकता है।

सहभागी	प्रमुख जिम्मेदारी
प्रधानाचार्य या नेतृत्व	योजना, संसाधन और जवाबदेही
नामित शिक्षक	गतिविधि, अभिलेख और संपर्क
स्वास्थ्यकर्मी	योग्य आकलन, सेवा और रेफरल
अभिभावक प्रतिनिधि	परिवार की जरूरत तथा सहयोग
विद्यार्थी प्रतिनिधि	अनुभव, सुझाव और सहपाठी सहभागिता
सहायक कर्मचारी	सफाई, भोजन या परिसर संबंधी कार्य

कार्य की स्पष्टता (Role Clarity)

बैठक में केवल समस्या लिखना पर्याप्त नहीं। कार्य, जिम्मेदार व्यक्ति, समय और पुनःसमीक्षा तय हों। उदाहरण के लिए पानी के नल की मरम्मत किसे करवानी है और कब उपयोग जाँचना है, यह स्पष्ट हो।

संसाधनों की निरंतरता (Sustained Resources)

साबुन, सफाई सामग्री, सुरक्षित प्राथमिक सहायता सामग्री और अभिलेख के लिए नियमित व्यवस्था चाहिए। एक बार मिले दान पर पूरा कार्यक्रम निर्भर रखना कठिन हो सकता है।

स्थानीय सहयोग (Local Partnerships)

निकट स्वास्थ्य केंद्र, आँगनवाड़ी और स्थानीय संस्थाओं से सहयोग कार्यक्रम को मजबूत कर सकता है। कोई बाहरी संस्था आए तो उसकी भूमिका और बच्चों की सुरक्षा स्पष्ट हो।

> समिति का मूल्य नामों की सूची में नहीं; जिम्मेदारी निभाने और सुधार पूरा करने में है।

शिक्षक की स्वास्थ्य संबंधी भूमिका

The Health Role of the Teacher

नियमित संपर्क का लाभ (Value of Daily Contact)

शिक्षक बच्चे के व्यवहार, सहभागिता और दैनिक स्थिति में परिवर्तन देख सकता है। बार-बार सिर-दर्द, कम सुनना, चश्मा न पहनना या भोजन से बचना स्वास्थ्य चर्चा का अवसर हो सकता है।

प्रमुख कार्य (Key Responsibilities)

कार्य	उदाहरण
निरीक्षण	नई कठिनाई और लगातार बदलाव पहचानना
स्वास्थ्य शिक्षा	आयु-अनुकूल संवाद और अभ्यास
सुविधा उपयोग में सहायता	पानी, शौचालय और अनुकूल बैठने का अवसर
परिवार से संपर्क	समस्या का तथ्यपूर्ण विवरण देना
सेवा से जोड़ना	आवश्यक रेफरल की प्रक्रिया समझाना
अनुवर्तन	सहायता मिलने और सहभागिता सुधरने की समीक्षा

उपयुक्त सीमा (Professional Boundaries)

शिक्षक केवल संकेत देखकर बीमारी का अंतिम नाम न लगाए। बच्चे का निजी परीक्षण, दवा देना या संवेदनशील जानकारी साझा करना निर्धारित अनुमति और योग्य सेवा के अनुसार होना चाहिए।

आदर्श व्यवहार (Modelling Healthy Behaviour)

सम्मानपूर्ण संवाद, हाथों की सफाई, समान सहभागिता और गलती पर सहायक प्रतिक्रिया रोज की स्वास्थ्य शिक्षा बनते हैं। बच्चे केवल कही बात नहीं, वयस्क का व्यवहार भी सीखते हैं।

विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक की स्वास्थ्य-संवर्धन भूमिका बढ़ सकती है, लेकिन उससे सभी चिकित्सीय कार्य करने का अधिकार स्वतः नहीं मिलता।

> शिक्षक स्वास्थ्य-समर्थक वातावरण और सेवा तक पहुँच का महत्त्वपूर्ण सहयोगी है; चिकित्सक का स्थानापन्न नहीं।

दैनिक स्वास्थ्य निरीक्षण

Daily Health Observation

उद्देश्य (Purpose of Daily Observation)

दैनिक निरीक्षण का अर्थ बच्चों को पंक्ति में खड़ा करके अपमानजनक सफाई-जाँच करना नहीं है। उद्देश्य ऐसे बदलाव पहचानना है जिनमें सहायता, विश्राम या शीघ्र चिकित्सा आवश्यक हो सकती है।

दिखाई देने वाला परिवर्तन	संभावित अगला कदम
असामान्य सुस्ती या बहुत अस्वस्थ दिखना	तुरंत स्थिति समझना और योग्य सहायता
लगातार खाँसी या कठिन श्वसन	गंभीरता के अनुसार स्वास्थ्य संपर्क
आँख-दर्द या बोर्ड न दिखना	दृष्टि से संबंधित चर्चा और जाँच
त्वचा की लगातार खुजली	परिवार से संपर्क तथा उचित सेवा
बार-बार अनुपस्थिति	स्वास्थ्य और अन्य बाधाओं की संवेदनशील समीक्षा

अवलोकन की सीमा (Limits of Observation)

पीलापन एनीमिया की आशंका दे सकता है, लेकिन पुष्टि नहीं है। चुप रहना हमेशा मानसिक विकार नहीं और खराब अंक हमेशा स्वास्थ्य समस्या नहीं हैं। कई कारण संभव होते हैं।

सुरक्षित प्रतिक्रिया (Safe Response)

बच्चे से शांत ढंग से पूछें, आवश्यक जानकारी लिखें और आयु-अनुकूल सहायता दें। गंभीर स्थिति में परिवार की साधारण बैठक की प्रतीक्षा न करें; तत्काल व्यवस्था सक्रिय हो।

गरिमा का संरक्षण (Respect and Dignity)

कपड़े, बाल या शरीर की स्थिति गरीबी और संसाधन की कठिनाई से जुड़ी हो सकती है। सहायता के बजाय दंड देना समस्या बढ़ा सकता है।

> निरीक्षण पहचान का पहला चरण है; निदान और कारण-निर्धारण के लिए उपयुक्त मूल्यांकन आवश्यक है।

प्रवेशकालीन और समय-समय पर स्वास्थ्य आकलन

Entry and Periodic Health Assessment

प्रवेश पर जानकारी (Entry Assessment)

विद्यालय प्रवेश के समय उपलब्ध स्वास्थ्य इतिहास, टीकाकरण, दीर्घकालीन बीमारी, एलर्जी और आवश्यक अनुकूलन की जानकारी उपयोगी है। उद्देश्य सुरक्षित सहभागिता की योजना बनाना है, बच्चे को अनुचित रूप से बाहर रखना नहीं।

आवधिक आकलन (Periodic Assessment)

नियत अंतराल पर योग्य स्वास्थ्यकर्मी द्वारा आयु और स्थानीय कार्यक्रम के अनुसार जाँच की जा सकती है। बार-बार जाँच की आवृत्ति केवल अनुमान से तय न करें; संबंधित कार्यक्रम और वास्तविक जरूरत देखें।

आकलन का पक्ष	जानकारी
वृद्धि और पोषण	आयु-अनुकूल माप तथा वृद्धि की प्रवृत्ति
दृष्टि और श्रवण	सीखने में बाधा देने वाली कठिनाई
दंत तथा त्वचा स्वास्थ्य	उपचार योग्य समस्याएँ
विकास और सहभागिता	गति, भाषा या सीखने की जरूरत
अन्य स्वास्थ्य दशाएँ	इतिहास और संकेत के अनुसार समीक्षा

स्क्रीनिंग और निदान (Screening versus Diagnosis)

स्क्रीनिंग अतिरिक्त मूल्यांकन की जरूरत पहचानती है। असामान्य परिणाम अंतिम रोग-निदान नहीं और सामान्य परिणाम हर समस्या अनुपस्थित होने की गारंटी नहीं है।

जाँच के बाद (After Assessment)

परिवार को परिणाम समझाएँ, जरूरी रेफरल दें और पूरा होने का अनुवर्तन करें। जाँच का दिन सफल तभी माना जाएगा जब उससे उपयोगी कार्रवाई जुड़े।

> स्वास्थ्य आकलन एक संपर्क है; कार्यक्रम की पूर्णता उपचार, सहयोग और पुनःसमीक्षा तक जाती है।

वृद्धि, BMI और पोषण का विद्यालयीय आकलन

Growth, BMI and Nutritional Assessment

माप की गुणवत्ता (Quality of Measurement)

वजन और ऊँचाई के लिए सही उपकरण, उपयुक्त स्थिति और सही आयु आवश्यक हैं। भारी वस्तु, गलत जूते या त्रुटिपूर्ण उपकरण परिणाम बदल सकते हैं। माप प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सम्मानपूर्ण ढंग से किया जाए।

बॉडी मास इंडेक्स (Body Mass Index: BMI)

> BMI = वजन (**kg**) ÷ [ऊँचाई (**m**)]²

24 किलोग्राम और 1.2 मीटर ऊँचाई वाले बच्चे का BMI होगा:

> BMI = 24 ÷ (1.2 × 1.2) ≈ 16.7 kg/m²

बच्चे की पोषण-श्रेणी केवल इस संख्या से तय नहीं की जाती। आयु और लिंग के अनुसार उपयुक्त BMI-for-age संदर्भ आवश्यक है। वयस्कों के स्थिर BMI कट-अंक बच्चों पर स्वतः लागू नहीं होते।

वृद्धि की प्रवृत्ति (Growth Trend)

5 से 19 वर्ष के लिए आयु-अनुकूल ऊँचाई और BMI संदर्भ उपलब्ध हैं। इस व्यापक आयु-सीमा में भार-के-लिए-आयु को हर आयु पर समान रूप से उपयोग नहीं किया जाता।

ध्यान का पक्ष	उद्देश्य
समय के साथ माप	वृद्धि का क्रम समझना
भोजन और स्वास्थ्य इतिहास	संभावित कारण पहचानना
अधिक या कम पोषण	उपयुक्त सहयोग तथा रेफरल
निजी जानकारी	सार्वजनिक तुलना और उपहास से बचाव

> बच्चों को वजन के आधार पर शर्मिंदा करने के बजाय स्वास्थ्य, वृद्धि और सुरक्षित सहभागिता पर ध्यान दें।

दृष्टि और श्रवण स्वास्थ्य

Vision and Hearing Health

सीखने में महत्त्व (Importance for Learning)

बोर्ड न दिखना, निर्देश न सुनना या आवाज पहचानने में कठिनाई पढ़ाई और संबंधों को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति को आलस्य, अवज्ञा या कम बुद्धि मान लेने से जरूरी सहायता छूट जाती है।

संकेत	उपयुक्त दिशा
बहुत पास से पुस्तक देखना	दृष्टि जाँच की जरूरत समझना
बोर्ड से बार-बार गलत नकल	दृष्टि तथा अन्य कारणों की समीक्षा
बार-बार बात दोहराने को कहना	श्रवण और कान का मूल्यांकन
लगातार कान-दर्द या बहाव	योग्य स्वास्थ्य सेवा
अचानक दृष्टि घटना या तेज आँख-दर्द	तत्काल चिकित्सा

स्क्रीनिंग की प्रक्रिया (Screening Process)

उपयुक्त प्रकाश, दूरी, मानकीकृत सामग्री और प्रशिक्षित कर्मी परीक्षण की गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं। शिक्षक द्वारा अनौपचारिक अवलोकन और मानकीकृत परीक्षण अलग हैं।

जाँच के बाद सहायता (Support after Screening)

जरूरत पर चश्मा, उपचार, श्रवण उपकरण या संचार का अनुकूलन उपलब्ध हो। केवल पर्ची देना पर्याप्त नहीं। देखें कि बच्चा साधन प्राप्त कर रहा है और उसे उपयोग करने में सहायता मिल रही है।

कक्षा में उपयुक्त बैठना, स्पष्ट निर्देश, दृश्य सामग्री और शोर कम करना सहायक हो सकता है। चश्मा या श्रवण उपकरण पहनने पर उपहास न होने दें।

> स्वास्थ्य जाँच का वास्तविक परिणाम बच्चे की पहुँच और सहभागिता में सुधार से दिखाई देता है।

दंत स्वास्थ्य, त्वचा और व्यक्तिगत स्वच्छता

Oral, Skin and Personal Hygiene

दंत स्वास्थ्य का स्थान (Oral Health)

दंत-दर्द भोजन, नींद और ध्यान प्रभावित कर सकता है। दूध के दाँत भी महत्त्वपूर्ण हैं। दंत-क्षय का उपचार और दैनिक सफाई दोनों आवश्यक हैं।

स्वास्थ्य पक्ष	विद्यालय में सहयोग
दाँत और मुख	सफाई का प्रदर्शन, मीठे संपर्क कम करने की शिक्षा और रेफरल
हाथ और नाखून	साबुन-पानी तथा अभ्यास का अवसर
त्वचा	लगातार खुजली या संक्रमण पर परिवार से संवेदनशील संपर्क
बाल	जरूरत पर उपयुक्त उपचार की जानकारी; अपमान से बचाव
कपड़े	स्वच्छता के साथ उपलब्ध संसाधन समझना

व्यवहार और सुविधा (Habits and Facilities)

उपयुक्त फ्लोराइड टूथपेस्ट से आयु-अनुकूल सफाई और मीठे खाद्य-पेय के बार-बार संपर्क में कमी उपयोगी है। विद्यालय के संदेश घर की परिस्थितियों से जुड़े हों।

त्वचा रोगों में अंतर (Different Skin Conditions)

हर खुजली संक्रामक नहीं है। स्केबीज, दाद और एक्जिमा के कारण तथा उपचार अलग हैं। शिक्षक निदान करने के बजाय योग्य जाँच से जोड़ सकता है।

समान गरिमा (Dignity)

बाल, नाखून या कपड़ों की स्थिति पर सार्वजनिक टिप्पणी स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है। सामग्री या पानी की कमी हो तो सहयोग की व्यवस्था करें।

> व्यक्तिगत स्वच्छता सिखाने के साथ आवश्यक सुविधा, सही उपचार और सम्मानपूर्ण व्यवहार उपलब्ध कराना जरूरी है।

रेफरल, उपचार और अनुवर्तन

Referral, Treatment and Follow-up

सेवा तक पहुँच का क्रम (Referral Pathway)

रेफरल किसी समस्या के लिए उपयुक्त उच्चतर या विशिष्ट सेवा से जोड़ने की प्रक्रिया है। केवल केंद्र का नाम लिख देना उसके पूरा होने के समान नहीं है।

1 पहचान और सूचना	देखे गए संकेत और जरूरत स्पष्ट करें।
2 उचित सेवा से संपर्क	परिवार को केंद्र और प्रक्रिया समझाएँ।
3 उपचार तक पहुँच	बाधाएँ समझकर उपलब्ध सहयोग जोड़ें।
4 अनुवर्तन और सहभागिता	सेवा, सहायता और विद्यालय-वापसी की समीक्षा करें।

प्रभावी रेफरल की जानकारी (Essential Information)

जानकारी	उपयोग
बच्चे की पहचान तथा आयु	सही सेवा और अभिलेख
देखे गए संकेत	समस्या का तथ्यपूर्ण विवरण
जरूरत की तात्कालिकता	सामान्य या शीघ्र सेवा का अंतर
कहाँ और कब जाना है	परिवार के लिए स्पष्ट दिशा
आगे की सूचना	उपचार और विद्यालयी सहयोग की समीक्षा

परिवार की बाधाएँ (Family Barriers)

परिवहन, समय, भाषा और खर्च के कारण परिवार सेवा तक न पहुँच पाए। इसे हमेशा लापरवाही न मानें। संबंधित स्वास्थ्यकर्मी या स्थानीय सहयोग से व्यवहारिक समाधान खोजें।

विद्यालय वापसी (Return to School)

उपचार के बाद चश्मा, बैठने की जगह, गतिविधि या दवा-संबंधी सहायता की जरूरत हो सकती है। जरूरी जानकारी उचित व्यक्ति तक ही पहुँचे।

> पहचान, रेफरल, सेवा प्राप्ति और अनुवर्तन के बीच की कड़ी पूरी होने पर ही कार्यक्रम बच्चे के लिए उपयोगी बनता है।

स्वास्थ्य अभिलेख और गोपनीयता

Health Records and Confidentiality

अभिलेख का उद्देश्य (Purpose of Health Records)

विद्यालयीय स्वास्थ्य अभिलेख समय के साथ जरूरत, सेवा और सुधार समझने का साधन है। इसमें केवल रोगों की सूची नहीं; आवश्यक अनुकूलन, रेफरल और अनुवर्तन की स्थिति भी उपयोगी है।

अभिलेख का पक्ष	उपयुक्त जानकारी
सामान्य पहचान	आयु, संपर्क और आवश्यक पारिवारिक सूचना
स्वास्थ्य इतिहास	प्रासंगिक बीमारी, एलर्जी और देखभाल-योजना
आकलन	तारीख, परीक्षण तथा योग्य व्यक्ति की टिप्पणी
रेफरल	कहाँ भेजा और सेवा मिली या नहीं
विद्यालयी सहायता	चश्मा, बैठने या गतिविधि का अनुकूलन
समीक्षा	सुधार तथा अगली कार्रवाई

तथ्य और अनुमान (Fact versus Assumption)

“आज बोर्ड पढ़ने में कठिनाई बताई” अवलोकन है। बिना परीक्षण “बच्चे की दृष्टि बहुत कमजोर है” अंतिम निदान जैसा कथन हो सकता है। अभिलेख में दोनों का अंतर बनाए रखें।

गोपनीयता (Confidentiality)

निजी जानकारी सुरक्षित रखें और केवल आवश्यक भूमिका वाले व्यक्ति तक साझा करें। बीमारी के नाम सार्वजनिक सूची या कक्षा में घोषित करना उचित नहीं है। संवेदनशील संवाद के लिए निजी और सुरक्षित स्थान हो।

सुरक्षा के गंभीर खतरे में उचित सेवाओं से आवश्यक जानकारी साझा करनी पड़ सकती है; पूर्ण गोपनीयता का ऐसा वादा न करें जिसे निभाना संभव न हो।

> उपयोगी अभिलेख संक्षिप्त, सही, अद्यतन और कार्रवाई से जुड़ा होता है; अधिक निजी जानकारी इकट्ठा करना उसका उद्देश्य नहीं है।

स्वस्थ भौतिक विद्यालय वातावरण

A Healthy Physical School Environment

भवन और कक्षा (Building and Classroom)

विद्यालय का स्थान, भवन, कमरे और आवागमन बच्चों की सुरक्षा तथा सुविधा के अनुरूप हों। पर्याप्त प्रकाश, वायु-संचार, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था और उपयोग योग्य फर्नीचर आवश्यक हैं।

पक्ष	स्वास्थ्य संबंधी उपयोग
प्रकाश	पढ़ना, लिखना और स्पष्ट देखना
वायु-संचार	आराम तथा वायु की गुणवत्ता
बैठने की व्यवस्था	आयु और शरीर के अनुरूप सुविधा
शोर का नियंत्रण	सुनना, ध्यान और संवाद
सुरक्षित फर्श तथा सीढ़ी	गिरने और चोट का जोखिम कम करना
सुलभ प्रवेश	अलग गतिशीलता जरूरत वाले बच्चों की पहुँच

आराम और शारीरिक उपयोग (Comfort and Ergonomics)

बच्चे को पैर और पीठ का आवश्यक सहारा मिले तथा कार्य-सतह उपयुक्त हो। लंबे समय एक ही मुद्रा में बैठना कम करने के लिए छोटे सक्रिय विराम उपयोगी हो सकते हैं।

रोशनी में चमक, बोर्ड की अस्पष्टता और भीड़ किसी बच्चे की समस्या बढ़ा सकते हैं। केवल पहली पंक्ति में बैठा देना हर दृष्टि या श्रवण जरूरत का पर्याप्त समाधान नहीं है।

रखरखाव (Maintenance)

टूटा फर्नीचर, खुले तार, फिसलन और खराब रेलिंग पर समय पर कार्रवाई हो। एक बार भवन बन जाने के बाद निरीक्षण समाप्त नहीं होता।

परिसर में पेड़, छाया और सुरक्षित खेल-स्थान उपयोगी हैं, लेकिन उनसे जुड़े रखरखाव और स्थानीय खतरे भी देखें।

> स्वस्थ वातावरण वह है जो वास्तव में सुरक्षित, सुलभ और उपयोग योग्य रहे; केवल निरीक्षण के दिन साफ दिखे इतना पर्याप्त नहीं है।

विद्यालय में जल, शौचालय और हाथ धोने की व्यवस्था

Water, Sanitation and Hand Hygiene

WASH के मुख्य घटक (Water, Sanitation and Hygiene)

पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की सुविधा और साफ परिसर विद्यालयीय स्वास्थ्य के मूल आधार हैं। सुविधा का होना और उसके उपयोग योग्य रहने में अंतर है।

घटक	आवश्यक विशेषता
पेयजल	सुरक्षित, पर्याप्त और बच्चों की पहुँच में
शौचालय	स्वच्छ, गोपनीय और आयु-अनुकूल
सुलभता	अक्षमता तथा अलग सहायता जरूरत के अनुसार सुविधा
हाथ धोना	पानी, साबुन और पर्याप्त समय
अपशिष्ट	सुरक्षित संग्रह और निस्तारण
रखरखाव	नियमित सफाई, मरम्मत और सामग्री

दैनिक व्यवहार (Daily Practice)

भोजन से पहले तथा शौच के बाद साबुन-पानी से हाथ धोने का अवसर हो। केवल संदेश लिख देने से अभ्यास नहीं बनता। कतार, नल की ऊँचाई और समय ऐसे हों कि सभी बच्चे सुविधा उपयोग कर सकें।

पानी की सुरक्षा (Safe Water)

सुरक्षित पानी भी गलत भंडारण या गंदे पात्र से दूषित हो सकता है। पानी निकालने तथा साझा पात्र के उपयोग में स्वच्छता बनाए रखें। गुणवत्ता की जाँच संबंधित व्यवस्था के अनुसार हो।

जवाबदेही (Accountability)

सफाई किसकी जिम्मेदारी है, साबुन कौन उपलब्ध करेगा और खराब नल की सूचना कहाँ जाएगी, यह स्पष्ट हो। बच्चों की सहभागिता शिक्षाप्रद हो, लेकिन असुरक्षित सफाई का भार उन पर न डालें।

> पानी और शौचालय तक सम्मानपूर्ण पहुँच स्वास्थ्य, उपस्थिति और समान सहभागिता तीनों को सहारा देती है।

मासिक धर्म स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण सुविधा

Menstrual Health and Dignified Facilities

स्वास्थ्य और सहभागिता (Menstrual Health and Participation)

मासिक धर्म सामान्य जैविक प्रक्रिया है। जानकारी का अभाव, दर्द, सामग्री की कमी और गोपनीय शौचालय न होना विद्यालयी सहभागिता बाधित कर सकते हैं। इसे अशुद्धता या शर्म का विषय बनाना उचित नहीं है।

आवश्यक सहयोग	व्यावहारिक रूप
तथ्यपूर्ण जानकारी	आयु-अनुकूल, सरल और सम्मानपूर्ण संवाद
गोपनीय सुविधा	सुरक्षित बदलने का स्थान तथा दरवाजे की व्यवस्था
पानी और सामग्री	हाथ तथा शरीर की सफाई और जरूरत पर सामग्री
सुरक्षित निस्तारण	स्थानीय व्यवस्था के अनुरूप संग्रह और निस्तारण
सहायक व्यक्ति	बिना उपहास प्रश्न पूछने का अवसर

दर्द और असामान्य संकेत (Pain and Concerns)

कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन बहुत अधिक दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, चक्कर या दैनिक कार्य में बड़ी बाधा को केवल सामान्य कहकर न टालें। योग्य स्वास्थ्य सलाह उपलब्ध हो।

विद्यालय का व्यवहार (School Response)

कक्षा से बाहर जाने, पानी या शौचालय उपयोग करने में अनावश्यक रोक न हो। सभी विद्यार्थियों को आयु-अनुकूल संवेदनशीलता सिखाने से उपहास और मिथक कम हो सकते हैं।

सामग्री बाँटना अकेला पर्याप्त उपाय नहीं; नियमित उपलब्धता, निजता और उपयोग योग्य सुविधाएँ भी आवश्यक हैं।

> मासिक धर्म स्वास्थ्य का सहयोग सम्मान, जानकारी, सुविधा और उचित चिकित्सा-संपर्क को एक साथ जोड़ता है।

विद्यालयीय भोजन और PM POSHAN

School Meals and PM POSHAN

योजना और उद्देश्य (School Nutrition Support)

PM POSHAN का संबंध पात्र सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बालवाटिका और कक्षा 1 से 8 तक बच्चों के पोषण-सहयोग से है। गर्म पका भोजन भूख कम करने, पोषण और विद्यालयी सहभागिता को सहारा देता है।

प्रति बच्चा, प्रति विद्यालय-दिवस मानक (Daily Nutrition Norms)

घटक	प्राथमिक: कक्षा 1 से 5	उच्च प्राथमिक: कक्षा 6 से 8
ऊर्जा	450 kcal	700 kcal
प्रोटीन	12 g	20 g

भोजन-सामग्री के मानक (Food Norms)

कच्ची खाद्य-सामग्री	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
खाद्यान्न	100 g	150 g
दाल	20 g	30 g
सब्जियाँ	50 g	75 g
तेल तथा वसा	5 g	7.5 g

नमक और मसाले आवश्यकता के अनुसार होते हैं। ये कच्ची सामग्री के मानक हैं; परोसे गए पके भोजन का कुल वजन इनके किसी एक मान के बराबर नहीं होता।

पोषण की सही व्याख्या (Interpretation)

विद्यालय का भोजन पूरे दिन की संपूर्ण आहार-आवश्यकता का विकल्प नहीं है। घर का भोजन, आहार की विविधता और संबंधित पोषण सेवाएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं।

स्थानीय मेनू में विविध अनाज, दाल और सब्जियों का उपयोग निर्धारित मानकों तथा उपलब्धता के अनुसार किया जा सकता है। वास्तविक खपत और भोजन की गुणवत्ता भी देखें।

> खाद्यान्न की मात्रा, भोजन की ऊर्जा और बच्चे की पूरी दैनिक आवश्यकता तीन अलग बातें हैं।

विद्यालयीय भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता

School Food Safety and Quality

सामग्री से परोसने तक (From Procurement to Serving)

सुरक्षित भोजन के लिए अच्छी सामग्री, सही भंडारण, स्वच्छ तैयारी और उचित परोसना साथ आवश्यक हैं। केवल भोजन के स्वाद से उसकी सुरक्षा तय नहीं होती।

चरण	प्रमुख सावधानी
प्राप्ति	सामग्री की गुणवत्ता और उपयुक्तता
भंडारण	नमी, कीट और रसायनों से सुरक्षित अलग स्थान
तैयारी	साफ पानी, हाथ, उपकरण और सतह
पकाना	पर्याप्त तथा समान पकना
परोसना	स्वच्छ बर्तन और दूषण से बचाव
समीक्षा	निर्धारित निरीक्षण तथा अभिलेख

जिम्मेदार निगरानी (Responsible Supervision)

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिम्मेदार वयस्क भोजन की गुणवत्ता तथा परोसने से पहले आवश्यक जाँच करें। बच्चों को संदिग्ध भोजन चखाकर सुरक्षा परखना उचित नहीं है। रसोई-कर्मियों को प्रशिक्षण, साफ पानी और आवश्यक सामग्री मिले।

समान व्यवहार (Equitable Meal Access)

भोजन में जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या अक्षमता के आधार पर भेदभाव न हो। खाने की व्यवस्था बच्चे के लिए सम्मानपूर्ण और सुलभ हो।

बीमारी की आशंका (Suspected Food-related Illness)

एक ही भोजन के बाद कई बच्चों में उलटी या दस्त हो तो तुरंत सुरक्षित देखभाल और स्वास्थ्य सेवा से संपर्क करें। संदिग्ध भोजन का उपयोग रोककर निर्धारित जाँच तथा सूचना प्रक्रिया अपनाएँ।

> भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, वास्तविक सेवन और समान पहुँच विद्यालयीय पोषण के आवश्यक अंग हैं।

पोषण शिक्षा और विद्यालय पोषण वाटिका

Nutrition Education and School Gardens

भोजन को समझना (Nutrition Education)

पोषण शिक्षा बच्चे को भोजन चुनने, विविधता समझने और सुरक्षित आदतें अपनाने में सक्षम बनाती है। केवल पोषक तत्वों के नाम याद करवाना पर्याप्त नहीं है।

गतिविधि	सीखने का पक्ष
स्थानीय भोजन पर चर्चा	उपलब्धता और विविधता
मेनू का अध्ययन	खाद्य समूहों का संयोजन
खाद्य-पैकेट का आयु-अनुकूल निरीक्षण	जानकारी पढ़ना और भ्रामक दावे पहचानना
भोजन की बर्बादी पर निरीक्षण	पसंद, परोसने की मात्रा और सुधार
रसोई या पोषण वाटिका	पौधे, स्वच्छता और भोजन से संबंध

पोषण वाटिका (School Nutrition Garden)

वाटिका से पौधों, मौसम और स्थानीय सब्जियों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। उसका उपयोग शिक्षण तथा उपलब्ध पोषण-सहयोग के लिए किया जा सकता है। यह निर्धारित विद्यालयीय भोजन की पूरी आपूर्ति का विकल्प नहीं है।

सुरक्षा और सहभागिता (Safe Participation)

गतिविधि आयु-अनुकूल हो। बच्चों से खतरनाक औजार, कीटनाशक या असुरक्षित श्रम न कराया जाए। अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए कार्य बदलकर सहभागिता दें।

परिवार से संबंध (Family Linkage)

महँगे भोजन को ही स्वस्थ बताना व्यावहारिक नहीं है। स्थानीय, उपलब्ध और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य विकल्पों पर चर्चा करें।

> अच्छी पोषण शिक्षा सही जानकारी को उपलब्ध भोजन, व्यवहार और परिवार की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ती है।

एनीमिया-निवारण और कृमिनाशन से जुड़ाव

Anaemia Prevention and Deworming Linkages

एनीमिया का प्रभाव (Anaemia and Function)

एनीमिया थकान, ध्यान और कार्यक्षमता प्रभावित कर सकता है। पीलापन संकेत हो सकता है, लेकिन सभी एनीमिया केवल आयरन की कमी से नहीं होते और केवल देखकर पुष्टि नहीं की जाती।

साप्ताहिक आयरन-फोलिक अम्ल सहयोग (WIFS)

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में साप्ताहिक आयरन-फोलिक अम्ल पूरकता (**Weekly Iron Folic Acid Supplementation**) एनीमिया की व्यापकता तथा गंभीरता घटाने का उपाय है। विद्यालय में निर्धारित दिन, प्रशिक्षित निगरानी और सही अभिलेख महत्त्वपूर्ण हैं।

खुराक, आयु और पात्रता लागू राष्ट्रीय तथा स्थानीय प्रोटोकॉल के अनुसार हों। शिक्षक अपने से मात्रा बदलकर या सभी बच्चों को एक ही योजना देकर उपचार न करें।

कार्यक्रम का पक्ष	विद्यालय की भूमिका
पूरक वितरण	सही पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया
स्वास्थ्य शिक्षा	आहार, आयरन और उपयुक्त उपयोग समझाना
निगरानी	अनुपस्थित या छूटे बच्चों की समीक्षा
गंभीर समस्या	स्वास्थ्य सेवा से जोड़ना
कृमिनाशन	नियत कार्यक्रम और सुरक्षित प्रक्रिया में सहयोग

कृमि और पोषण (Worms and Nutrition)

कृमिनाशन के साथ शौचालय, हाथों की सफाई, जूते और सुरक्षित भोजन महत्त्वपूर्ण हैं। बार-बार संक्रमण रोकने के लिए वातावरण सुधार आवश्यक है।

> विद्यालयी पूरकता जनस्वास्थ्य उपाय है; गंभीर एनीमिया या विशिष्ट बीमारी का व्यक्तिगत उपचार अलग आवश्यक हो सकता है।

विद्यालयी आयु में टीकाकरण का सहयोग

Supporting School-age Immunization

विद्यालय की भूमिका (School Linkage)

विद्यालय टीकाकरण कार्ड की समीक्षा, परिवार को जानकारी, सेवा से संपर्क और छूटी खुराकों की पूर्ति में सहयोग कर सकता है। टीका देना प्रशिक्षित और अधिकृत स्वास्थ्य सेवा का कार्य है।

आयु या समूह	प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम संबंध
5 से 6 वर्ष	DPT बूस्टर-2
10 वर्ष	Td
14 वर्ष पूर्ण, 15 से कम आयु की बालिकाएँ	2026 के राष्ट्रीय HPV कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण
16 वर्ष	Td
अन्य छूटी खुराकें	आयु और पूर्व अभिलेख के अनुसार पूर्ति-योजना

सूचित परिवार और सही अभिलेख (Information and Records)

कार्यक्रम की पात्रता, स्थान और प्रक्रिया परिवार को स्पष्ट करें। लागू सहमति और स्वास्थ्य-समीक्षा की व्यवस्था स्वास्थ्य टीम के अनुसार हो। बच्चों को डराकर या स्वास्थ्य जानकारी सार्वजनिक करके सहभागिता न कराएँ।

सुरक्षित सत्र (Safe Sessions)

उपयुक्त टीका, शीत-श्रृंखला, प्रशिक्षित कर्मी और गंभीर प्रतिकूल घटना के प्रबंधन की तैयारी आवश्यक है। टीके के बाद हुई प्रत्येक घटना स्वयं टीके के कारण सिद्ध नहीं होती; उचित मूल्यांकन चाहिए।

पूरक और टीका (Supplement versus Vaccine)

पोषण पूरक और कृमिनाशक टीके नहीं हैं। एक ही विद्यालयी संपर्क पर अलग स्वास्थ्य गतिविधियाँ होने से उनका उद्देश्य समान नहीं हो जाता।

> विद्यालय की सफलता बच्चों को सही जानकारी और योग्य सेवा तक पहुँचाने में है, स्वतंत्र चिकित्सीय निर्णय लेने में नहीं।

संक्रामक रोग नियंत्रण और विद्यालय-वापसी

Infection Control and Return to School

नियमित निवारण (Routine Prevention)

हाथों की सफाई, पर्याप्त वायु-संचार, सुरक्षित भोजन-पानी, टीकाकरण और उचित बीमारी-संपर्क नीति संक्रमण का जोखिम घटाते हैं। सभी संक्रमण समान मार्ग से नहीं फैलते।

परिस्थिति	विद्यालय की उपयुक्त प्रतिक्रिया
अस्वस्थ बच्चा	स्थिति समझना, आराम और परिवार से संपर्क
कठिन श्वसन या गंभीर सुस्ती	तत्काल योग्य सहायता
कई समान मामले	स्वास्थ्य सेवा को सूचना और घटनाक्रम दर्ज करना
निर्दिष्ट संक्रामक रोग	रोग-विशिष्ट निर्देश के अनुसार कार्रवाई
उपचार के बाद वापसी	स्वास्थ्य स्थिति और आवश्यक सलाह की समीक्षा

प्रकोप की पहचान (Recognizing Clusters)

एक ही कक्षा, समय या भोजन से जुड़े कई मामलों पर ध्यान दें। केवल अनुपस्थिति से कारण निश्चित नहीं किया जा सकता। संदिग्ध रोग का योग्य मूल्यांकन तथा स्थानीय स्वास्थ्य निर्देश आवश्यक हैं।

सम्मान और गोपनीयता (Respect and Privacy)

संक्रमण का डर बच्चे या परिवार का सार्वजनिक बहिष्कार करने का कारण न बने। आवश्यक जानकारी संबंधित व्यक्ति तक सीमित रखें।

विद्यालय बंद करना, विशेष अलगाव या सभी संपर्कों का उपचार हर बीमारी में आवश्यक नहीं है। ऐसे निर्णय योग्य प्राधिकारी तथा स्वास्थ्य सेवा की सलाह से होते हैं।

> संक्रमण नियंत्रण का उद्देश्य सुरक्षित सीखना और उचित देखभाल है; बिना प्रमाण भय, दंड या भेदभाव बढ़ाना नहीं।

दीर्घकालीन रोग और व्यक्तिगत देखभाल-योजना

Chronic Conditions and Individual Care Plans

समावेशी स्वास्थ्य सहयोग (Support for Chronic Conditions)

अस्थमा, मधुमेह, मिर्गी या अन्य दीर्घकालीन दशा वाले बच्चे को शिक्षा और खेल में सहभागिता के लिए विशेष योजना चाहिए हो सकती है। रोग का नाम बच्चे की संपूर्ण क्षमता तय नहीं करता।

योजना का भाग	आवश्यक जानकारी
सामान्य जरूरत	भोजन, पानी, गतिविधि और विश्राम
उपचार-सहयोग	पर्चे तथा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार जिम्मेदारी
बिगड़ने के संकेत	कब और किसे सहायता के लिए बुलाना है
आपात कार्रवाई	प्रशिक्षित कर्मी और निर्धारित व्यवस्था
संपर्क	परिवार तथा स्वास्थ्य सेवा की जानकारी

रोग-विशिष्ट उदाहरण (Examples)

अस्थमा में व्यक्तिगत उपचार-योजना और सही इनहेलर तकनीक का सहयोग उपयोगी है। मधुमेह में भोजन तथा उपचार का समय महत्त्वपूर्ण हो सकता है। दौरे वाले बच्चे में सुरक्षित प्राथमिक सहायता और व्यक्तिगत आपात योजना चाहिए।

स्पष्ट सीमाएँ (Defined Responsibilities)

दवा का भंडारण, देना और अभिलेखन लागू नियमों, परिवार की सहमति और स्वास्थ्य टीम की योजना से हों। शिक्षक अपनी तरफ से मात्रा या उपचार न बदलें।

सामाजिक सहभागिता (Participation)

अनावश्यक रूप से खेल से बाहर रखना या रोग का नाम कक्षा में घोषित करना उचित नहीं है। जरूरत के अनुसार गतिविधि अनुकूल करें और उपहास रोकें।

> व्यक्तिगत योजना का उद्देश्य बच्चे को सुरक्षित रखते हुए सामान्य विद्यालयी जीवन में अधिकतम भागीदारी देना है।

मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श और बुलिंग-निवारण

Mental Health, Counselling and Bullying Prevention

सहायक सामाजिक वातावरण (Supportive School Climate)

अपनापन, सुरक्षित संवाद और सम्मानपूर्ण संबंध मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देते हैं। बार-बार अपमान, भय और उत्पीड़न सीखने तथा स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

ध्यान देने योग्य परिवर्तन (Changes to Notice)

लगातार उदासी, अत्यधिक भय, अचानक अलगाव, नींद या व्यवहार में बड़ा बदलाव और दैनिक कार्य में बाधा पर संवेदनशील चर्चा करें। किसी एक घटना से मानसिक विकार का अंतिम निष्कर्ष न निकालें।

विद्यालयीय उपाय	उद्देश्य
भरोसेमंद वयस्क	सहायता माँगने का सुरक्षित अवसर
स्पष्ट उत्पीड़न-निवारण नीति	हानि और शक्ति-असंतुलन रोकना
सहपाठी सहयोग	अपनापन और सहभागिता
योग्य परामर्श से जुड़ाव	जरूरत पर विशेष सहायता
परिवार से समन्वय	अलग परिस्थितियों की जानकारी

बुलिंग और सामान्य मतभेद (Bullying versus Conflict)

बार-बार हानि और शक्ति के असंतुलन वाली स्थिति को सामान्य बराबरी का झगड़ा न मानें। बच्चे की सुरक्षा और संस्थागत कार्रवाई आवश्यक हो सकती है। पीड़ित बच्चे को दोष देना उचित नहीं है।

शिक्षक की सीमा (Teacher's Role)

शिक्षक सुन सकता है, प्रारंभिक सहयोग दे सकता है और योग्य सेवा से जोड़ सकता है। स्वयं मनोचिकित्सीय निदान या उपचार करना उसकी सामान्य भूमिका नहीं है।

> मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक परामर्श-कक्ष के साथ रोज की कक्षा में सुरक्षा, सम्मान और अपनापन भी आवश्यक हैं।

बाल सुरक्षा और हिंसा से संरक्षण

Child Safety and Protection from Violence

सुरक्षित विद्यालय (Safe School)

शारीरिक हिंसा, अपमान, यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन हानि और असुरक्षित अनुशासन से संरक्षण विद्यालयीय स्वास्थ्य का आवश्यक भाग है। बच्चे को सुरक्षा के लिए भरोसेमंद वयस्क तथा स्पष्ट सहायता-मार्ग उपलब्ध हों।

व्यवस्था	उद्देश्य
आयु-अनुकूल सुरक्षा शिक्षा	व्यक्तिगत सीमा और सहायता माँगना समझना
स्पष्ट शिकायत-मार्ग	बिना डर परेशानी बताना
कर्मचारियों का जिम्मेदार व्यवहार	सुरक्षित संबंध और उचित सीमा
आवश्यक गोपनीयता	बच्चे को अनावश्यक सार्वजनिक चर्चा से बचाना
गंभीर चिंता पर सेवा-संपर्क	संरक्षण और योग्य सहायता

बच्चे की बात सुनना (Listening to the Child)

बच्चा परेशानी बताए तो शांत रहें, उसे दोष न दें और बार-बार विस्तृत विवरण बताने का दबाव न बनाएँ। सुरक्षा सुनिश्चित करके निर्धारित बाल-सुरक्षा और आवश्यक रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पालन करें।

रोकथाम का वातावरण (Prevention-oriented Environment)

एकांत असुरक्षित स्थान, निगरानी की कमी और अस्पष्ट जिम्मेदारी की समीक्षा हो। अनुशासन में हिंसा या सार्वजनिक अपमान को स्वास्थ्य शिक्षा का उपाय नहीं मानना चाहिए।

सुरक्षा का पूरा भार बच्चे की “सावधानी” पर न डालें। संस्थागत जिम्मेदारी और समय पर प्रतिक्रिया आवश्यक हैं।

> बाल सुरक्षा में विश्वास, रोकथाम, उचित प्रतिक्रिया और संरक्षण सेवाओं से जुड़ाव सभी शामिल हैं।

समावेशन और विशेष स्वास्थ्य जरूरतें

Inclusion and Special Health Needs

अर्थपूर्ण सहभागिता (Meaningful Inclusion)

समावेशन केवल विद्यालय में नामांकन नहीं है। भवन, शिक्षण, संचार और स्वास्थ्य सहायता ऐसी हो कि अलग जरूरत वाला बच्चा भी अर्थपूर्ण रूप से भाग ले सके।

जरूरत	संभावित अनुकूलन
गतिशीलता	सुलभ मार्ग, शौचालय और उपयुक्त बैठना
दृष्टि	स्पष्ट सामग्री, आवश्यक आकार और सहायक साधन
श्रवण	स्पष्ट संवाद, दृश्य संकेत और उपयुक्त स्थान
सीखने या भाषा की कठिनाई	छोटे चरण, अतिरिक्त समय और वैकल्पिक अभिव्यक्ति
दीर्घकालीन रोग	व्यक्तिगत स्वास्थ्य-योजना और प्रशिक्षित सहयोग

समानता और न्याय (Equality and Equity)

सभी बच्चों को एक जैसा साधन देना हमेशा समान अवसर नहीं बनाता। जरूरत के अनुसार अधिक या अलग सहयोग देना न्यायपूर्ण सहभागिता का भाग है।

परिवार और विशेषज्ञ से समन्वय (Collaborative Planning)

बच्चे की रुचि, क्षमता और पसंद भी लक्ष्य में शामिल हों। परिवार तथा आवश्यक विशेषज्ञ के साथ व्यवहारिक योजना बनाएँ और समय पर उसकी समीक्षा करें।

पहचान और निदान (Identification and Diagnosis)

विद्यालयीय स्क्रीनिंग या शिक्षक की सूची सहायता की जरूरत बता सकती है। औपचारिक निदान योग्य मूल्यांकन से होता है; पहचान के बाद उचित समर्थन रोकना भी सही नहीं है।

> समावेशी स्वास्थ्य कार्यक्रम बाधाएँ घटाता है और बच्चे की शक्ति को उपयोग में लाने का अवसर बढ़ाता है।

शारीरिक सक्रियता, विश्राम और दिनचर्या

Physical Activity, Rest and Daily Routines

सक्रिय जीवनशैली (Active Lifestyle)

नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय, मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य के साथ ध्यान, मनोदशा तथा सामाजिक सहभागिता को भी सहारा देती है। विद्यालय का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिता के लिए प्रतिभाशाली बच्चों को चुनना नहीं, सभी बच्चों को सुरक्षित सक्रियता के अवसर देना है।

5 से 17 वर्ष के बच्चों और किशोरों के लिए सप्ताह भर में औसतन प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट मध्यम से तीव्र शारीरिक गतिविधि का लक्ष्य रखा जाता है। इसमें अधिकांश गतिविधि एरोबिक प्रकृति की होती है। यह समय खेल, चलने, नृत्य और अन्य गतिविधियों से मिलकर पूरा हो सकता है; एक ही सत्र में पूरा करना आवश्यक नहीं है।

विद्यालय में व्यावहारिक व्यवस्था

क्षेत्र	उपयुक्त व्यवस्था
खेल और शारीरिक शिक्षा	आयु तथा क्षमता के अनुसार विविध गतिविधियाँ
लंबे समय तक बैठना	पढ़ाई के बीच छोटे सक्रिय विराम
समावेशन	दिव्यांगता या स्वास्थ्य जरूरत के अनुसार अनुकूलित खेल
सुरक्षा	सुरक्षित मैदान, पानी और मौसम के अनुसार गतिविधि
सहभागिता	तुलना और दंड के स्थान पर सहयोग तथा आनंद

पर्याप्त विश्राम का महत्व

नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, सीखने में कठिनाई और दुर्घटना का जोखिम बढ़ सकता है। विद्यालय समय-सारणी में अध्ययन, भोजन, खेल और विश्राम का संतुलन रखे तथा परिवार को नियमित सोने-जागने की आदत समझाए। लगातार असामान्य थकान को केवल आलस्य न माना जाए।

> शारीरिक गतिविधि को दंड के रूप में देना, बीमारी में जबरन व्यायाम कराना या खेल के दौरान पानी रोकना स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य के विरुद्ध है।

प्राथमिक उपचार और आपातकालीन तैयारी

First Aid and Emergency Preparedness

प्राथमिक उपचार का उद्देश्य (First Aid)

दुर्घटना या अचानक बीमारी के बाद उपलब्ध साधनों से दी गई प्रारंभिक सहायता का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना, स्थिति बिगड़ने से रोकना और उपयुक्त चिकित्सा तक पहुँच बनाना है। यह प्रशिक्षित चिकित्सा का विकल्प नहीं है। विद्यालय को घटना होने से पहले जिम्मेदारियाँ और संपर्क व्यवस्था तय करनी चाहिए।

तैयार विद्यालय की विशेषताएँ

व्यवस्था	आवश्यक तैयारी
प्रशिक्षित जिम्मेदार व्यक्ति	सहायता देने और मदद बुलाने की भूमिका स्पष्ट
प्राथमिक उपचार सामग्री	व्यवस्थित, सुलभ और नियमित जाँच की गई सामग्री
संपर्क सूची	परिवार, निकट स्वास्थ्य सुविधा और स्थानीय आपात सेवा
सुरक्षित पहुँच	एम्बुलेंस या परिवहन के लिए प्रवेश मार्ग
स्वास्थ्य सूचना	जरूरी एलर्जी या लिखित देखभाल योजना की सुरक्षित उपलब्धता

घटना के समय कार्रवाई

पहले स्थान की सुरक्षा देखें। बिजली, आग, यातायात या अन्य खतरे के बीच बिना सुरक्षा के प्रवेश न करें। बच्चे की प्रतिक्रिया, साँस और गंभीर रक्तस्राव जैसी स्थिति के अनुसार प्रशिक्षित व्यक्ति सहायता दे तथा जरूरत पड़ते ही आपात चिकित्सा बुलाए। अन्य बच्चों की भीड़ हटाएँ और परिवार को सूचना दें।

बेहोशी, साँस की गंभीर कठिनाई, गंभीर चोट या तेजी से बिगड़ती अवस्था में उपचार की प्रतीक्षा करते हुए केवल घर भेज देना पर्याप्त नहीं है। बेहोश व्यक्ति को मुँह से पानी, भोजन या दवा न दें।

घटना के बाद समीक्षा

समय, देखे गए संकेत, दी गई सहायता और रेफरल का तथ्यात्मक अभिलेख रखें। घटना के कारणों और सहायता में देरी की समीक्षा करके सुरक्षा व्यवस्था सुधारें।

> प्राथमिक उपचार पेटी रखने के साथ प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास और स्पष्ट रेफरल व्यवस्था भी आवश्यक है।

विद्यालय में आपदा और दुर्घटना प्रबंधन

School Disaster and Accident Management

जोखिम की पहचान (Risk Assessment)

आपदा तैयारी भवन, स्थान और स्थानीय परिस्थितियों से जुड़ी होती है। आग, भूकंप, बाढ़, तेज गर्मी, तूफान तथा आसपास के यातायात या औद्योगिक जोखिम अलग-अलग विद्यालयों में अलग महत्व रख सकते हैं। योजना स्थानीय सक्षम प्राधिकरण के निर्देशों और विद्यालय की वास्तविक जरूरतों के अनुसार बने।

जोखिम घटाने की व्यवस्था

ढीले विद्युत तार, बंद निकास, असुरक्षित सीढ़ियाँ, खुले जलाशय, टूटा खेल उपकरण और रसायनों का गलत भंडारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ाते हैं। केवल चेतावनी-पट्ट लगाने के स्थान पर कारण हटाना प्राथमिक उपाय होना चाहिए।

चरण	विद्यालय की कार्रवाई
पूर्व तैयारी	सुरक्षित मार्ग, जिम्मेदार दल और संपर्क व्यवस्था तय करना
अभ्यास	बच्चों को शांत ढंग से आयु-अनुकूल अभ्यास कराना
घटना के दौरान	परिस्थिति के अनुसार सुरक्षित स्थान या निकासी
उपस्थिति की पुष्टि	सुरक्षित स्थान पर बच्चों और कर्मचारियों की गिनती
परिवार से पुनर्मिलन	पहचान सत्यापित कर निर्धारित प्रक्रिया से सुपुर्दगी

समावेशी तैयारी

चलने, देखने, सुनने या समझने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए सहायता पहले से तय हो। निकासी के दौरान आवश्यक उपकरण तथा व्यक्ति की जरूरत पर ध्यान दें। सहपाठी सहयोग उपयोगी है, लेकिन वयस्क जिम्मेदारी केवल बच्चों को न सौंपें।

अभ्यास से सीखना

अभ्यास के बाद मार्ग में बाधा, संचार की कमी और गिनती में त्रुटि की समीक्षा करें। डर पैदा करने वाला नाटकीय प्रदर्शन उपयोगी तैयारी का विकल्प नहीं है। घटना के बाद शारीरिक सुरक्षा के साथ भावनात्मक सहारा और पढ़ाई में वापसी की योजना भी जरूरी है।

> हर परिस्थिति में एक ही प्रतिक्रिया उपयुक्त नहीं होती। आग, भूकंप और बाढ़ के लिए स्थानीय निर्देशों के अनुसार अलग सुरक्षा उपाय आवश्यक हो सकते हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन-कौशल

Health Education and Life Skills

ज्ञान से व्यवहार तक (Health Education)

स्वास्थ्य शिक्षा बच्चे को जानकारी देने के साथ उसका अर्थ समझने, निर्णय लेने और सुरक्षित व्यवहार अपनाने की क्षमता विकसित करती है। केवल रोगों के नाम याद करा देना पर्याप्त नहीं है। सामग्री आयु, भाषा, सांस्कृतिक संदर्भ तथा बच्चों की वास्तविक समस्याओं के अनुरूप होनी चाहिए।

समझ	अभ्यास	व्यवहार
Understand	Practise	Apply
कारण और सही जानकारी	सुरक्षित वातावरण में कौशल	दैनिक जीवन में उपयोग और समीक्षा

प्रभावी शिक्षण विधियाँ

विधि	उपयुक्त उपयोग
प्रदर्शन और अभ्यास	हाथ धोना, मुख स्वच्छता और सुरक्षित भोजन व्यवहार
भूमिका-अभिनय	सहायता माँगना, दबाव का सामना और सम्मानपूर्ण संवाद
कहानी और परिस्थिति-चर्चा	भावनाएँ, समानता तथा व्यवहार के परिणाम समझना
परियोजना	पानी की उपलब्धता या विद्यालय स्वच्छता का सुरक्षित अध्ययन
चित्र और स्थानीय सामग्री	कम पढ़ने वाले या अलग भाषा वाले बच्चों की सहभागिता

जीवन-कौशल का संबंध

आत्म-जागरूकता, सहानुभूति, समस्या-समाधान, विवेकपूर्ण निर्णय, प्रभावी संचार और तनाव से निपटना स्वास्थ्य व्यवहार को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, पोषण संबंधी विज्ञापन का मूल्यांकन करने में जानकारी के साथ तर्क और निर्णय की जरूरत होती है।

मूल्यांकन और प्रतिक्रिया

शिक्षक केवल परिभाषा पूछने के स्थान पर देखें कि बच्चा उपयुक्त व्यवहार समझा और कर पा रहा है या नहीं। हाथ धोने के प्रदर्शन में क्रम, साबुन का उपयोग और सभी हिस्सों की सफाई पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। सीखने की कठिनाई पर दोबारा अभ्यास कराएँ।

> व्यक्तिगत बीमारी, शरीर, पारिवारिक परिस्थिति या निजी अनुभव सार्वजनिक रूप से बताने के लिए बच्चे को बाध्य न करें। उदाहरण और चर्चा सम्मानजनक तथा सुरक्षित हों।

आयुष्मान भारत का विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

The School Health and Wellness Programme

स्वास्थ्य और शिक्षा का समन्वय

आयुष्मान भारत के अंतर्गत विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम (**School Health and Wellness Programme**) फरवरी 2020 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विद्यालयों में स्वास्थ्य संवर्धन और रोग-निवारण संबंधी व्यवहार विकसित करना तथा स्वास्थ्य और शिक्षा तंत्र का समन्वय बढ़ाना है।

कार्यक्रम की व्यवस्था सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यान्वयन योजना के अनुसार लागू होती है। किसी विद्यालय में वास्तविक क्रियान्वयन का आकलन स्थानीय प्रशिक्षण, गतिविधियों और सहयोगी सेवाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की घोषणा को प्रत्येक विद्यालय में समान क्रियान्वयन का प्रमाण न मानें।

स्वास्थ्य एवं कल्याण दूत

चयनित विद्यालय में दो प्रशिक्षित शिक्षक, अधिमानतः एक पुरुष और एक महिला, स्वास्थ्य एवं कल्याण दूत (**Health and Wellness Ambassadors**) की भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों के साथ सहभागी और रुचिकर गतिविधियाँ संचालित करते हैं।

प्रमुख व्यवस्था	आशय
प्रशिक्षित शिक्षक	स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी सत्रों का संचालन
11 विषय	शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य
साप्ताहिक समय	निर्धारित रूप से प्रति सप्ताह एक घंटे की गतिविधियाँ
सहभागी पद्धति	चर्चा, खेल, भूमिका-अभिनय और अनुभव आधारित सीखना
सेवा से संबंध	आवश्यकता होने पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क

कार्यक्रम की सीमा और उपयोगिता

शिक्षक का प्रशिक्षण उसे चिकित्सक नहीं बनाता। निदान, औषधि निर्धारण और चिकित्सा प्रक्रियाएँ योग्य स्वास्थ्यकर्मियों की जिम्मेदारी रहती हैं। कार्यक्रम का महत्व दैनिक व्यवहार और विद्यालय संस्कृति में स्वास्थ्य को स्थान देने में है।

> स्वास्थ्य शिक्षा सत्र, चिकित्सीय जाँच और किसी बच्चे का व्यक्तिगत उपचार अलग गतिविधियाँ हैं; इनके बीच उचित समन्वय जरूरी है।

स्वास्थ्य एवं कल्याण के विषय: प्रथम भाग

Health and Wellness Themes: Part One

विषय 1 से 6 की समझ

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के विषय आपस में जुड़े हैं। इन्हें अलग-अलग तथ्यों की सूची के रूप में पढ़ाने के बजाय बच्चों के अनुभव और व्यवहार से जोड़ना उपयोगी है। नीचे पहले छह विषयों का शैक्षिक आशय दिया गया है।

विषय	प्रमुख शैक्षिक आशय
स्वस्थ रूप से बड़ा होना (**Growing Up Healthy**)	वृद्धि, विकास, शरीर में परिवर्तन और व्यक्तिगत देखभाल
भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य (**Emotional Well-being and Mental Health**)	भावनाओं की पहचान, तनाव से निपटना और सहायता लेना
पारस्परिक संबंध (**Interpersonal Relationships**)	सम्मान, सहानुभूति, संवाद और सहयोग
मूल्य एवं उत्तरदायी नागरिकता (**Values and Responsible Citizenship**)	जिम्मेदारी, सम्मान तथा सामूहिक हित
लैंगिक समानता (**Gender Equality**)	समान अवसर और रूढ़ धारणाओं का विवेकपूर्ण मूल्यांकन
पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (**Nutrition, Health and Sanitation**)	भोजन, स्वच्छ आदतें और स्वस्थ परिवेश

कक्षा में समेकित उदाहरण

कक्षा मिलकर पानी बचाने और हाथ धोने की व्यवस्था पर काम करती है। इसमें स्वच्छता का ज्ञान, समूह में संवाद, जिम्मेदारी बाँटना और सभी को समान अवसर देना एक साथ सीखने को मिलते हैं। यह केवल सफाई पर भाषण देने से अधिक व्यावहारिक अनुभव है।

शिक्षण में सावधानी

बच्चों की शरीर-रचना, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्वरूप और सामाजिक पृष्ठभूमि अलग हो सकती है। शिक्षक किसी एक अनुभव को सबका अनुभव न माने। भाषा ऐसी हो कि बच्चा प्रश्न पूछ सके और गलत धारणा दूर कर सके।

> स्वस्थ विकास की शिक्षा में वैज्ञानिक जानकारी, आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति सम्मान एक साथ शामिल रहते हैं। तुलना या उपहास सीखने में बाधा बनता है।

स्वास्थ्य एवं कल्याण के विषय: द्वितीय भाग

Health and Wellness Themes: Part Two

विषय 7 से 11 की समझ

इन विषयों में जोखिम पहचानने, सहायता प्राप्त करने और सुरक्षित निर्णय लेने पर बल दिया जाता है। शिक्षण का उद्देश्य भय या शर्म पैदा करना नहीं, उम्र के अनुसार वैज्ञानिक समझ और व्यावहारिक क्षमता विकसित करना है।

विषय	प्रमुख शैक्षिक आशय
मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन (**Prevention and Management of Substance Misuse**)	जोखिम, साथी-दबाव, मना करना और मदद लेना
स्वस्थ जीवनशैली का संवर्धन (**Promotion of Healthy Lifestyle**)	गतिविधि, विश्राम और टिकाऊ स्वस्थ आदतें
प्रजनन स्वास्थ्य एवं HIV की रोकथाम (**Reproductive Health and HIV Prevention**)	आयु-अनुकूल वैज्ञानिक जानकारी और गलत धारणाओं का निराकरण
हिंसा और चोटों के विरुद्ध सुरक्षा (**Safety and Security against Violence and Injuries**)	असुरक्षित स्थिति पहचानना तथा विश्वसनीय सहायता
इंटरनेट, उपकरण और सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग (**Promotion of Safe Use of Internet, Gadgets and Media**)	गोपनीयता, ऑनलाइन व्यवहार और डिजिटल जोखिम

संवेदनशील विषयों का शिक्षण

प्रजनन स्वास्थ्य में शरीर के सामान्य बदलावों की सही जानकारी दें। HIV के बारे में स्पष्ट करें कि सामान्य सामाजिक संपर्क, साथ बैठने या भोजन साझा करने से संक्रमण नहीं फैलता। किसी व्यक्ति की स्थिति के आधार पर भेदभाव स्वीकार्य नहीं है।

डिजिटल सुरक्षा का उदाहरण

यदि किसी बच्चे को ऑनलाइन धमकी या निजी सामग्री माँगने वाला संदेश मिले, तो वह विश्वसनीय वयस्क की सहायता प्राप्त करे। शिक्षक दोषारोपण के बजाय सुरक्षा, गोपनीयता और उचित सहायता पर ध्यान दे।

> रोकथाम संबंधी शिक्षा में सहायता लेने की क्षमता आवश्यक है। बच्चे को प्रत्येक जोखिम अकेले संभालने की जिम्मेदारी देना उचित नहीं है।

स्वास्थ्य दूत और विद्यार्थियों की सहभागिता

Health Ambassadors and Student Participation

शिक्षक स्वास्थ्य दूत की भूमिका

स्वास्थ्य एवं कल्याण दूत का कार्य सत्र लेना, बच्चों की सहभागिता बढ़ाना, संवेदनशील वातावरण बनाना और विद्यालय की स्वास्थ्य गतिविधियों में समन्वय करना है। उसे संबंधित प्रशिक्षण सामग्री, निर्धारित विषयों और उपलब्ध सेवा-संपर्क की जानकारी होनी चाहिए।

शिक्षक बच्चों के प्रश्नों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करे। किसी प्रश्न का उत्तर न मालूम हो तो अनुमान को तथ्य बनाकर प्रस्तुत करने के बजाय विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करे। व्यक्तिगत परेशानी सामने आने पर उसे सार्वजनिक चर्चा का विषय न बनाए।

विद्यार्थी प्रतिनिधि और सहपाठी सहयोग

कार्यक्रम में छात्र स्वास्थ्य एवं कल्याण संदेशवाहक (**Health and Wellness Messengers**) तथा अन्य छात्र गतिविधियाँ स्वास्थ्य संदेशों को साथियों तक पहुँचाने में मदद कर सकती हैं। इनके माध्यम से बच्चों को सहभागिता और नेतृत्व का अवसर मिलता है।

उपयुक्त छात्र भूमिका	वयस्क जिम्मेदारी
हाथ धोने और पानी बचाने का संदेश	पानी, साबुन और रखरखाव उपलब्ध कराना
स्वास्थ्य गतिविधि में सहपाठी सहयोग	गतिविधि की सुरक्षा और समावेशन
पोस्टर या नाटक प्रस्तुत करना	वैज्ञानिक शुद्धता और संवेदनशील भाषा
समस्या के बारे में शिक्षक को बताना	शिकायत पर उपयुक्त कार्रवाई

सीमाएँ और सुरक्षा

बच्चों से सहपाठियों की बीमारी की गोपनीय सूची बनवाना, निजी स्वास्थ्य जानकारी पूछवाना, दवा दिलवाना या दूसरों को दंडित कराना उपयुक्त नहीं है। विद्यार्थी प्रतिनिधि सहयोगी हैं, चिकित्सक या अनुशासन निरीक्षक नहीं।

निरंतर सहयोग

स्वास्थ्य दूत को प्रधानाध्यापक, अन्य शिक्षक, परिवार और स्वास्थ्यकर्मियों का सहयोग मिले। शिक्षकों के बदलने पर प्रशिक्षण और जिम्मेदारी का हस्तांतरण आवश्यक है।

> बच्चों की सहभागिता तभी अर्थपूर्ण है जब उनके सुझाव सुने जाएँ और वयस्क अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाएँ।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंध

Linkages with RBSK

प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (**Rashtriya Bal Swasthya Karyakram: RBSK**) जन्म से 18 वर्ष तक बच्चों में चुनी हुई स्वास्थ्य समस्याओं की जल्दी पहचान, उपचार से जोड़ने और अनुवर्तन के लिए कार्य करता है। वर्तमान RBSK 2.0 में चार व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत 32 स्वास्थ्य अवस्थाएँ सम्मिलित हैं।

चार क्षेत्र (4 Ds)	आशय
जन्मजात दोष (**Defects at Birth**)	जन्म से उपस्थित संरचनात्मक या कार्यात्मक समस्याएँ
रोग (**Diseases**)	बचपन में पाई जाने वाली चुनी हुई बीमारियाँ
कमियाँ (**Deficiencies**)	पोषण या विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी
विकास में विलंब (**Developmental Delays**)	विकास, कार्यक्षमता और संबद्ध कठिनाइयाँ

विद्यालय और सेवा के बीच संपर्क

सरकारी विद्यालयों सहित निर्धारित सामुदायिक स्थलों में स्क्रीनिंग तथा जरूरत पर रेफरल इसकी व्यवस्था से जुड़े हैं। जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (**District Early Intervention Centre: DEIC**) आकलन, हस्तक्षेप और आगे की सेवाओं से संबंध बनाने में भूमिका निभाता है।

विद्यालय की व्यावहारिक तैयारी

विद्यालय संबंधित दल से समन्वय कर बच्चों की उपलब्धता, परिवार तक सूचना और आवश्यक अभिलेख की व्यवस्था करे। अनुपस्थित बच्चे, विद्यालय बदलने वाले बच्चे या रेफरल तक न पहुँच पाने वाले परिवार सहायता से छूट न जाएँ। सेवा में देरी के कारण समझना केवल सूची पूरी करने से अधिक उपयोगी है।

स्वास्थ्य शिक्षा से अंतर

स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम मुख्यतः व्यवहार और स्वास्थ्य संवर्धन के शैक्षिक सत्रों पर बल देता है। RBSK में स्क्रीनिंग और आवश्यक हस्तक्षेप से जोड़ना प्रमुख है। दोनों एक-दूसरे को सहारा दे सकते हैं।

> किसी बच्चे को स्क्रीनिंग में चिन्हित करना अंतिम निदान नहीं है। परिवार को अगली सेवा और अनुवर्तन की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।

परिवार, समुदाय और विभागीय समन्वय

Family, Community and Intersectoral Coordination

साझा जिम्मेदारी (Shared Responsibility)

विद्यालय में सीखी गई आदतों को परिवार और समुदाय का सहयोग मिलने पर निरंतरता मिलती है। दूसरी ओर विद्यालय, परिवार की आर्थिक कठिनाई या सेवा तक पहुँच की बाधा समझकर अपनी योजना अधिक व्यावहारिक बना सकता है। समन्वय का अर्थ दोष बाँटना नहीं, समस्या का समाधान जोड़ना है।

सहभागी	संभावित योगदान
अभिभावक और देखभालकर्ता	स्वास्थ्य जानकारी, नियमित दिनचर्या और उपचार का सहयोग
विद्यालय प्रबंधन समिति	प्राथमिकताओं, सुविधाओं और स्थानीय सहयोग पर चर्चा
स्वास्थ्यकर्मी	आकलन, परामर्श, टीकाकरण और रेफरल सहयोग
स्थानीय निकाय	पानी, सफाई, कचरा तथा आसपास की सुरक्षा से जुड़ा कार्य
समुदाय के सहयोगी	सुरक्षित गतिविधियों और संसाधनों में पारदर्शी सहयोग

प्रभावी संवाद

अभिभावक बैठक में सामान्य स्वास्थ्य विषय समझाए जा सकते हैं, जबकि किसी बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी अलग और गोपनीय ढंग से साझा की जाए। संदेश सरल भाषा में दें; केवल कठिन तकनीकी शब्दों वाला पर्चा परिवार के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।

सेवा तक पहुँच की बाधाएँ

परिवहन, काम से छुट्टी, भाषा, दिव्यांगता, स्वास्थ्य सुविधा का समय और उपचार का भय रेफरल पूरा होने में बाधा बन सकते हैं। विद्यालय उपलब्ध सेवाओं की सही जानकारी, समय पर सूचना और संपर्क की मदद दे सकता है।

जवाबदेही और निरंतरता

किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है, कब तक कार्रवाई होगी और अगली समीक्षा कब होगी, यह स्पष्ट रखें। सहयोग को किसी एक उत्साही शिक्षक तक सीमित रखने पर उसके स्थानांतरण से व्यवस्था रुक सकती है।

> समुदाय की सहभागिता में बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजी जानकारी की रक्षा हमेशा बनी रहनी चाहिए।

गतिविधि-योजना और वार्षिक कैलेंडर

Activity Planning and the Annual Calendar

नियोजन का व्यावहारिक आधार

गतिविधि-योजना में जरूरत, उद्देश्य, जिम्मेदार व्यक्ति, आवश्यक सामग्री और समीक्षा का समय जोड़ा जाता है। विद्यालय का आकार, मौसम, परीक्षा, स्थानीय स्वास्थ्य जोखिम तथा उपलब्ध सेवाएँ समय-सारणी को प्रभावित करती हैं। बहुत सारी गतिविधियाँ लिख देना प्रभावी कार्यक्रम का प्रमाण नहीं है।

नीचे दिया गया कैलेंडर एक उदाहरण है। इसे सार्वभौमिक सरकारी अनिवार्यता या हर विद्यालय के लिए समान आवृत्ति न माना जाए। स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य सेवाओं का समय संबंधित कार्यक्रम तथा स्थानीय व्यवस्था के अनुसार तय होगा।

अवधि	उदाहरणात्मक गतिविधि
प्रतिदिन	सुरक्षित पानी, कार्यशील शौचालय, भोजन स्वच्छता और अस्वस्थ बच्चे पर ध्यान
प्रति सप्ताह	स्वास्थ्य एवं कल्याण सत्र, सक्रिय सहभागिता और छोटी समीक्षा
प्रति माह	सुविधा-रखरखाव, लंबित रेफरल और सामग्री की समीक्षा
सत्र या आवश्यकता अनुसार	स्वास्थ्य दल से समन्वय, परिवार संवाद और सुरक्षा अभ्यास
वर्ष के अंत में	उपलब्धि, छूटे बच्चों, कठिनाइयों और अगली योजना का विश्लेषण

निर्धारित कार्यक्रम और उदाहरण में अंतर

विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम में प्रति सप्ताह एक घंटे की गतिविधि का प्रावधान है। तालिका की दूसरी गतिविधियों की आवृत्ति उदाहरण के रूप में दी गई है; उन्हें उसी कार्यक्रम का समान अनिवार्य नियम न समझें।

संसाधन और वैकल्पिक व्यवस्था

यदि साबुन की आपूर्ति रुकती है तो केवल हाथ धोने का सत्र दोहराना समस्या हल नहीं करेगा। बजट, खरीद और आपूर्ति की जिम्मेदारी ठीक करनी होगी। छुट्टी, शिक्षक अनुपस्थिति या भवन मरम्मत की स्थिति के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था सोचें।

> स्वास्थ्य दिवस उपयोगी अवसर हैं, लेकिन नियमित सेवाओं और रोज की सुविधाओं का स्थान नहीं ले सकते।

निगरानी, मूल्यांकन और संकेतक

Monitoring, Evaluation and Indicators

प्रक्रिया और परिणाम (Monitoring and Evaluation)

निगरानी से पता चलता है कि काम तय तरीके से चल रहा है या नहीं। मूल्यांकन से उद्देश्य की उपलब्धि, उपयोगिता तथा सुधार की जरूरत समझी जाती है। केवल गतिविधियों की गिनती से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार सिद्ध नहीं होता।

स्तर	विद्यालयीय उदाहरण
संसाधन (**Input**)	प्रशिक्षित व्यक्ति, बजट और आवश्यक सामग्री
प्रक्रिया (**Process**)	तय सत्र, जाँच या रखरखाव का संचालन
प्रत्यक्ष उपलब्धि (**Output**)	जाँच किए गए बच्चे या पूर्ण हुए सत्र
निकट परिणाम (**Outcome**)	रेफरल पूरा होना या स्वच्छ व्यवहार में सुधार
व्यापक प्रभाव (**Impact**)	लंबे समय में बेहतर स्वास्थ्य और सहभागिता

संकेतकों की गणना

> स्क्रीनिंग कवरेज (%) = जाँच किए गए पात्र बच्चे ÷ कुल पात्र बच्चे × 100

यदि 400 पात्र बच्चों में 360 की जाँच हुई, तो स्क्रीनिंग कवरेज 360 ÷ 400 × 100 = 90% होगा। पात्र समूह तथा मापन की अवधि स्पष्ट होनी चाहिए।

> रेफरल पूर्णता (%) = निर्धारित अवधि में सेवा तक पहुँचे बच्चे ÷ उसी समूह के कुल रेफर बच्चे × 100

यदि रेफर किए गए 75 बच्चों में 60 सेवा तक पहुँचे, तो पूर्णता 60 ÷ 75 × 100 = 80% होगी। सेवा तक पहुँचना और सफल उपचार दोनों अलग बातें हैं।

परिणाम की सावधान व्याख्या

अनुपस्थिति घटने पर स्वास्थ्य कार्यक्रम का योगदान संभव है, लेकिन मौसम, परिवहन और परीक्षा जैसे अन्य कारण भी देखे जाएँ। अनुपस्थित बच्चों का रिकॉर्ड छूटने पर कवरेज कृत्रिम रूप से अच्छा दिख सकता है। औसत के साथ अलग जरूरत वाले समूहों की पहुँच भी जाँचें।

> उपयोगी संकेतक स्पष्ट, मापने योग्य और कार्रवाई से जुड़े हों; गलत या अधूरी संख्या केवल उपलब्धि का भ्रम देती है।

समेकित विद्यालयीय योजना का उदाहरण

An Integrated School Action Plan

एक विद्यालय की स्थिति

एक विद्यालय में भोजन से पहले हाथ धोने की जगह पर पानी अनियमित है। कुछ बच्चे बोर्ड पढ़ने में कठिनाई बताते हैं। स्वास्थ्य जाँच में रेफर किए गए कई बच्चे अगली सेवा तक नहीं पहुँचे। इन समस्याओं का समाधान एक स्वास्थ्य शिविर लगाकर पूरा नहीं होगा।

समस्या से कार्रवाई तक

पहचानी गई जरूरत	समन्वित कार्रवाई
हाथ धोने की सुविधा बाधित	जलापूर्ति, साबुन, रखरखाव और जिम्मेदार व्यक्ति तय करना
स्वच्छता व्यवहार कमजोर	प्रदर्शन, अभ्यास और भोजन से पहले समय देना
बोर्ड पढ़ने में कठिनाई	योग्य दृष्टि-जाँच से जोड़ना और बैठने की उपयुक्त व्यवस्था
रेफरल अधूरा	परिवार से बाधा समझकर सेवा-संपर्क और अनुवर्तन
कुछ बच्चों की अनुपस्थिति	कारण समझना तथा आवश्यक शैक्षिक और स्वास्थ्य सहयोग

तीनों घटकों का संबंध

हाथ धोने की विधि समझाना स्वास्थ्य शिक्षा है। पानी और साबुन उपलब्ध कराना स्वस्थ वातावरण की व्यवस्था है। दृष्टि-जाँच तथा आवश्यक सेवा से जोड़ना स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा है। इनका समन्वय कार्यक्रम को व्यवहार में प्रभावी बनाता है।

समीक्षा का तरीका

चार सप्ताह बाद केवल सत्रों की संख्या न गिनें। देखें कि पानी उपलब्ध रहा या नहीं, बच्चे सुविधा उपयोग कर पाए या नहीं और कितने रेफरल आगे बढ़े। यह अवधि उदाहरण है; वास्तविक समीक्षा समस्या और योजना के अनुसार तय होगी।

परिवारों से मिली जानकारी के आधार पर समय या संपर्क व्यवस्था बदली जा सकती है। दृष्टि संबंधी सहायता मिलने के बाद पढ़ाई में सहभागिता पर भी ध्यान दें।

> समस्या पहचानना शुरुआत है। जिम्मेदार कार्रवाई, सेवा तक पहुँच और अनुवर्तन से ही पहचान का लाभ बच्चे तक पहुँचता है।

प्रमुख भेद और समग्र दृष्टिकोण

Key Distinctions and a Holistic Perspective

संबंधित अवधारणाओं की स्पष्टता

विद्यालयीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में कई गतिविधियाँ जुड़ी रहती हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और जिम्मेदारियाँ समान नहीं होते। सही भेद समझने से योजना, अभिलेख और मूल्यांकन अधिक स्पष्ट बनते हैं।

अवधारणाएँ	मुख्य अंतर
स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा	पहली समझ तथा व्यवहार विकसित करती है; दूसरी योग्य आकलन और देखभाल से जुड़ी है
स्क्रीनिंग और निदान	पहली संभावित समस्या चिन्हित करती है; दूसरा उपयुक्त चिकित्सीय आकलन से निर्धारित होता है
रेफरल और अनुवर्तन	पहला अगली सेवा तक भेजना है; दूसरा आगे की स्थिति और सहायता पर ध्यान रखना है
सुविधा और कार्यशील सुविधा	शौचालय बना होना तथा पानी, सफाई और पहुँच के साथ उपयोग योग्य होना अलग है
विद्यालयीय भोजन मानक और दैनिक जरूरत	भोजन योजना का योगदान पूरे दिन की व्यक्तिगत पोषण आवश्यकता के बराबर नहीं है
गतिविधि और स्वास्थ्य परिणाम	सत्र या जाँच की संख्या तथा स्वास्थ्य में सुधार अलग उपलब्धियाँ हैं
शिक्षक स्वास्थ्य दूत और स्वास्थ्यकर्मी	शिक्षण तथा समन्वय की भूमिका चिकित्सीय निदान या उपचार का अधिकार नहीं बनती

कार्यक्रम की गुणवत्ता

गुणवत्ता का आकलन नियमितता, वैज्ञानिक शुद्धता, समावेशन, गोपनीयता, सेवा तक पहुँच और रखरखाव के आधार पर करें। केवल साफ दिखने वाला परिसर पर्याप्त नहीं; भावनात्मक सुरक्षा और सम्मानजनक व्यवहार भी स्वस्थ विद्यालय का हिस्सा हैं।

निरंतर सुधार की प्रक्रिया

जरूरत पहचानें, प्राथमिकता तय करें, योजना लागू करें और परिणाम देखकर सुधार करें। बच्चों तथा परिवारों की प्रतिक्रिया इसमें मूल्यवान है। संसाधनों की कमी को दर्ज करके समाधान खोजें, उसे किसी बच्चे की गलती न बनाएँ।

> प्रभावी विद्यालयीय स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चे के स्वास्थ्य, सीखने, गरिमा और सुरक्षित सहभागिता को एक साथ सहारा देता है।